

INDICADO POR: Dr. Bruno (Cardio)
 MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
 NS 22222395786 | 142

CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO

IDADE: 52 PESO: 84 ALTURA: 1,73 PROFISSÃO:
 SINTOMAS: Sonolência diurna, cansaço
 QUEIXAS: Distúrbios noturnos / Insônia
 MEDICAMENTOS: não utiliza
 MÉDICO: Dr. Bruno (Cardio)
 MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: (X) S () N
 EXERCÍCIO FÍSICO: 5-6x por semana
 HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 2 S JANTAR: 20 h
 HORA QUE DORME: 21-21:30 h HORA QUE ACORDA: 6-6:30 h
 COCHILO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE
 TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N
 BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () N X NA SEMANA () N
 FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: normal
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal
 OVERLAP: não MALLAMPATI: III
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
 HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
 (N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:
 POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

25/03/25 Análise de localização Elite
 P=7 cmH₂O Natacha

01/04/25 P=7 cmH₂O
 IAH=0,8 cmH₂O
 m de uso: 2h30'
 fuga: 10,1 l/min
 - Relata fobia a máscara
 - não conseguiu dormir algumas noites
 - Oriento colocar o equipamento durante o dia
 Natacha

12/05/25 P=6 cmH₂O
 IAH=0,7 cmH₂O
 m de uso: 4h30'
 fuga: 16 l/min
 usando bem / sem queixas

Comprei CPAP Elite S10 e continua locando Silva
 CPAP auto.

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado
Sonofisio - SONOFISIO

Telefone +55 12 3921-1001

Paciente

Nome Carlos Cesar Dos Santos Sorato
Nascimento 05/06/1972 (52 anos)
Sexo Masculino

Exame

Início 10/03/2025 - 22:02:31
Fim 11/03/2025 - 05:41:27
Tempo total 07:38:56 (458,9 min)
Tempo válido 07:31:05 (451,1 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/03/2025

Peso 84 kg
Altura 1,73 m
IMC 28,1

Medicamentos

Não respondido

Sintomas

Respondido em 10/03/2025

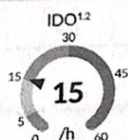
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☒ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

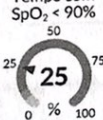
Não respondido

- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Tempo com SpO₂ < 90%



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 10/03/2025, iniciado às 22:02 e terminado às 05:41. O tempo total de registro foi de 7h38min (458 minutos) e o tempo válido foi de 7h31min (451 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 115 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 15,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 25% do tempo de registro (115 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 4% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 15,3/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

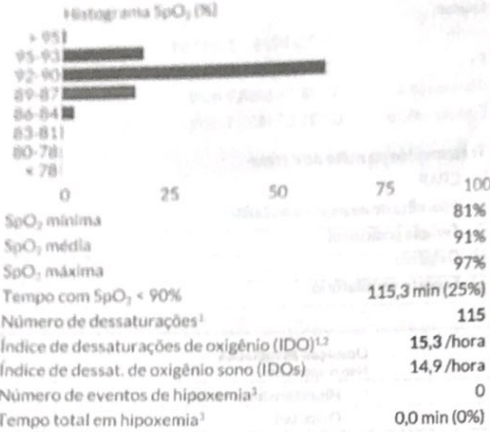
Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).



Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Oximetria (SpO₂)



Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴: 65,6 %min/hora

Risco cardiovascular

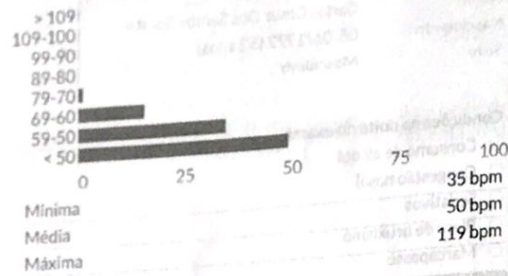
66 %min/hora

0 Risco menor

Risco maior 300+

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Sono estimado

Tempo total de sono: 355,5 min
 Tempo para dormir: 35,0 min
 Tempo acordado pós-sono: 66,0 min
 Eficiência do sono: 78%

Análise de ronco

Tempo de gravação: 459,0 min
 Tempo com ronco: 18,4 min (4%)



Polissonogramas

